

TEMA 6.16 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Traumatismo ORL

PERFIL EUNACOM 4.02.7.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trauma Otorrinolaringológico: El Tímpano y la Barometría

Las disrupciones mecánicas (físicas o presuradas) de la membrana timpánica constituyen motivos de urgencia primaria ORL, siendo su manejo fundamentalmente médico observador pero de agudo diferencial on/off con los traumatismos craneo-encefálicos graves.

1. La Perforación Timpánica Traumática Directa

- **El Mecanismo de Acción EUNACOM (La Mano y el Hisopo):** La fisonomía patognomónica relata un "Golpe contuso directo sobre la oreja, habitualmente un manotazo con la palma ahuecada/abierta" (causa compresión súbita letal de aire que estalla e implosiona el tímpano) o bien la inserción yatrogénica auto-infligida de "Un cotonito, hisopo o cuerpo rectilíneo en el conducto". - **Semiotecnia y Dx Clínico:** - El paciente experimenta de súbito intenso dolor (Otalgia), disminución auditiva (Hipoacusia de tipo conductiva porque la membrana transmisora no vibra bien) y el sangrado directo de la herida (Otorragia). - El diagnóstico oro se realiza visuo-espacialmente mediante **OTOSCOPIA**, evidenciando la laceración de la membrana timpánica. - **La Disyuntiva EUNACOM TEC vs Tímpano (¡Red Flag!):** Si el paciente sufre un atropello, accidente de alto tránsito o impacto severo craneal concusivo y presenta Otorragia y Sordera, **NO ES UNA PERFORACIÓN TIMPÁNICA SIMPLE**. Corresponde al signo patognomónico agudo de una Fractura de Base de Cráneo (Hueso Temporal) de un TEC GRAVE. - **Manejo Clínico Conservador:** - Se deja en **OBSERVACIÓN**. La inmensa mayoría de las membranas regeneran sus capas escamosas solas. - Se prescriben Analgésicos. - **Medida de Prevención EUNACOM Oro:** Prohibición estricta de oclusión o ducha abierta en ese oído. **¡NO SE PUEDE MOJAR!** (El baño se realiza con tapones o algodón embarrilado protector en vaselina, previniendo infecciones del oído medio). - Se Deriva al Otorrinolaringólogo de urgencia **SÓLO** si existen **Red Flags de lesión de oído interno:** Si asocia Vértigo/Mareo, Hipoacusia profunda Sensorio-Neural o Tinnitus intenso (sospechando "Fístula de Perilinfia").

2. El Barotrauma Timpánico (Trauma por Diferencial de Presión Otorrinológica)

- **Historia Desencadenante (La Atmósfera Abrupta):** Producida por la deficiente igualación de las presiones mediante la Tuba de Eustaquio. El cuadro asolórico se desencadena tras **BUCEOS profundos** o **VUELOS EN AVIÓN** (descompresión de cabinas o ascensos/descensos bruscos), subir montañas altas rápidamente o

exposiciones agudas a ondas expansivas de explosiones. - **Clínica de la Inflamación Barométrica:** En adición a la hipoacusia por ocupación de cámara y el dolor tensorial; el tímpano frecuentemente revienta sus microvasos sub epiteliales manifestando en la otoscopia un **HEMOTÍMPANO** (Se evidencia la membrana indemne pero coloreada oscura violácea traslúcida demostrando atrapamiento sanguinolento en el interior del Oído Medio) o en defectos un tímpano severamente Retraído o Abombado. - **Terapéutica Barotraumática:** - Resolutivo estricto por observación (Regresión espontánea). - Tratamiento sintomático en AINES. - La derivación a especialidad asila los mismos patrones del trauma de oído interno directos: Red Flags vestibulares si asoma Vértigo, cofosis o Hipoacusias sensorio-neurales súbitas que adviertan el rasgamiento y la fístula a nivel de ventanas oval o redonda internas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un boxeador de veinte años recibe un golpe en la nariz. Al día siguiente tiene dolor nasal, equimosis infraocular derecha e inspección de la nariz muestra una masa rojiza fluctuante que abomba el interior de la fosa nasal derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y la urgencia?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Traumatismo ORL. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fractura nasal: deformación + equimosis infraocular; equimosis infraocular NO es signo del mapache
- Signo del mapache: equimosis bilateral periorbital bilateral de TEC severo; la fractura nasal da equimosis unilateral infraocular
- Hematoma del tabique nasal es urgencia: el cartílago avascular se nutre del pericondrio y se necrosa si se despegas
- Hematoma del tabique: masa fluctuante rojiza que abomba la fosa nasal; drena quirúrgicamente de urgencia
- Sin drenaje del hematoma de tabique: necrosis cartilaginosa con deformidad en silla de montar
- Hematoma del pabellón auricular: misma urgencia; necrosis cartilaginosa produce oreja en coliflor
- Tratamiento hematoma auricular: drenaje quirúrgico urgente más vendaje compresivo circular

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMATISMO ORL)**PREGUNTA 1**

Un boxeador de veinte años recibe un golpe en la nariz. Al día siguiente tiene dolor nasal, equimosis infraocular derecha e inspección de la nariz muestra una masa rojiza fluctuante que abomba el interior de la fosa nasal derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y la urgencia?

- A)** Fractura nasal; reducir en los próximos cinco días cuando ceda el edema
- B)** Hematoma del tabique nasal; drenaje quirúrgico urgente para prevenir necrosis cartilaginosa
- C)** Sinusitis aguda postraumática; tratar con antibióticos y descongestivos
- D)** Epistaxis posterior por fractura de lámina cribosa; taponamiento posterior urgente
- E)** Fractura del tabique nasal; reducción quirúrgica en la próxima semana

PREGUNTA 2

Un luchador de judo de dieciocho años consulta dos días después de un golpe en la oreja derecha. Tiene el pabellón auricular inflamado con una masa fluctuante que borra los relieves normales de la oreja. ¿Cuál es el tratamiento?

- A)** Aplicar hielo y analgésicos; el hematoma se reabsorberá solo
- B)** Drenaje quirúrgico urgente del hematoma más vendaje compresivo circular
- C)** Antibióticos endovenosos por sospecha de pericondritis
- D)** Observar durante una semana; si persiste, derivar a cirugía plástica
- E)** Punción aspiración con aguja fina sin vendaje posterior

PREGUNTA 3

Un paciente que recibió un puñetazo en la nariz tiene equimosis periorbital derecha al día siguiente. ¿Cuál es el hallazgo que distingue la equimosis de la fractura nasal del signo del mapache del TEC?

- A)** El signo del mapache del TEC es unilateral mientras que la fractura nasal da equimosis bilateral
- B)** La equimosis de la fractura nasal es infraocular y unilateral; el signo del mapache es bilateral y periorbital
- C)** No hay diferencia; ambos producen equimosis periorbital bilateral
- D)** El signo del mapache se acompaña de rinorrea, lo que lo diferencia de la fractura nasal
- E)** La fractura nasal produce equimosis tardía a los cinco días; el signo del mapache es inmediato

RESUMEN: TRAUMATISMO ORL

El traumatismo ORL comprende tres entidades principales: la fractura nasal, el hematoma del tabique nasal y el hematoma del pabellón auricular. La fractura nasal es la más frecuente de los huesos faciales. Se presenta con antecedente de trauma, dolor, deformación nasal y equimosis infraocular. Esta equimosis infraocular no debe confundirse con el signo del mapache, que es bilateral y se asocia a traumatismo encefalocraneano severo. El diagnóstico es clínico y la reducción puede realizarse en los primeros dos a tres días antes de que se fije el hueso, o bien diferirse hasta cuatro a cinco días cuando ya ha cedido el edema para permitir mejor evaluación. El hematoma del tabique nasal es una urgencia verdadera. Ocurre cuando la sangre se acumula entre el pericondrio y el cartílago del tabique. El cartílago es avascular y recibe su nutrición exclusivamente del pericondrio; si el hematoma lo despegga, el cartílago queda sin nutrición y se necrosa. Esto produce la deformidad en silla de montar del tabique nasal. El diagnóstico es por inspección directa del tabique nasal: se ve una masa fluctuante rojiza que abomba la fosa nasal. El tratamiento es drenaje quirúrgico urgente con incisión y evacuación del hematoma, seguido de taponamiento para prevenir la reacumulación. El hematoma del pabellón auricular también es urgencia. La misma lógica aplica: el cartílago del pabellón auricular recibe su nutrición del pericondrio, y si el hematoma lo separa, el cartílago se necrosa y produce la deformidad conocida como oreja en coliflor, que es característica de los deportistas de lucha. El tratamiento es drenaje quirúrgico urgente con incisión, evacuación y vendaje compresivo circular para prevenir la reacumulación.